三、肠扭转

1.概述

①肠袢及其系膜过长、系膜根部附着处过窄或粘连收缩靠拢、肠内容物骤增、肠管动力异常、**突然改变体位**

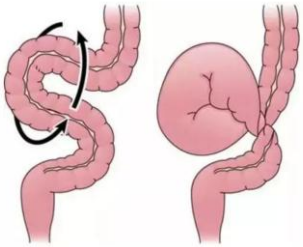
②小肠、盲肠、横结肠以顺时针扭转多见，乙状结肠以逆时针扭转多见。小肠扭转最多见小肠占地面积大

乙逆时针，其他都是顺时针

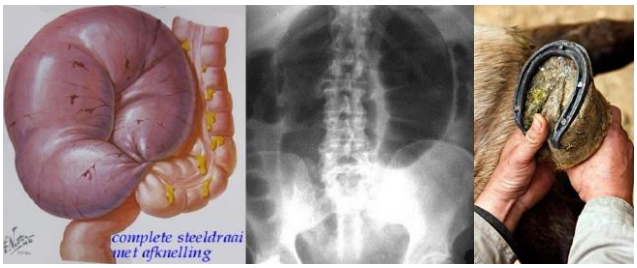
2.可能可能最可能（ttsx 青年人打篮球-小肠-年龄小 VS 老年人打太极-大肠-年龄大）

青年饱餐后剧烈运动多致小肠扭转	粪石、肿瘤便秘的老年运动多致乙状结肠扭转
回转复位扭转肠袢 **若坏死→肠切除+一期吻合术** 相对干净	**钡灌肠（兼治疗作用）鸟嘴征，X 线马蹄状巨大双腔充气肠袢** **回转复位扭转肠袢，若坏死→肠切除+造口**二期再处理（脏）





肠子的两端不通，叫做闭袢性梗阻



马蹄状巨大双腔充气肠袢



鸟嘴征：
①贲门失弛缓症：做钡餐出现鸟嘴
②乙状结肠扭转：做钡灌肠出现鸟嘴

肠梗阻是经典的水盐电解质失衡（细胞外液减少），不仅容易发生低血容量休克，毒素一入血（肠道细菌多）还导致感染性休克

四、治疗

1.**最基本：禁食补液、胃肠减压** 最基础

2.手术

（1）已**绞窄**病例题中一般关注腹膜刺激征即可

持续腹痛伴阵发加剧，压痛**固定** 挂了不动了

X 线孤立固定的肿大肠袢（不随时间变化）

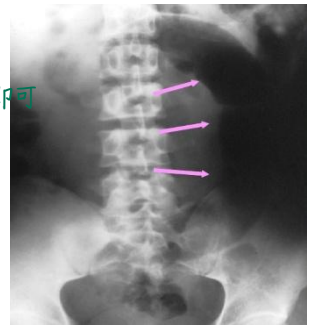
肠子坏死绞窄穿孔，肠内压力骤降

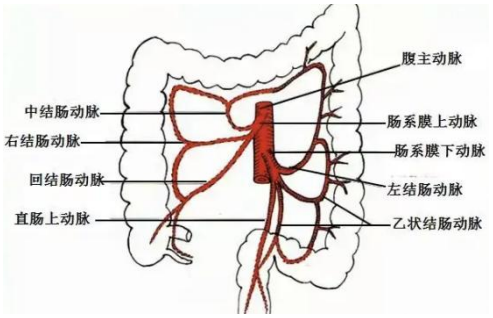
腹痛可暂时减轻、随后出现**腹膜炎**

早期休克 肠道每天分泌大量液体

血性呕吐物、排泄物、腹水

带血的东西说明已经绞窄





（2）易绞窄

①急性完全性梗阻 又急又完全

②肠套叠 肠套叠的类型很多，都易绞窄，但只有大肠套大肠才属于闭袢

一端是回盲瓣挡着
一端是梗阻部位

③**闭袢性梗阻：肠扭转、大肠完全梗阻、结肠-结肠型套叠、逆行性嵌顿疝、急性完全性输入袢梗阻**（出现肠绞窄如腹膜炎→手术，否则先保守治疗、无效再手术）

XXXX

见于毕Ⅰ式手术

④有心脏疾患的老年人：**房颤**等病史→**栓塞肠系膜上动脉**等（以中结肠动脉常见）→急腹症：**症征不符**（早期腹痛等症状严重、腹部体征轻微）→**腹腔动脉造影** 局部充盈缺损

病变还没扩展到壁层腹膜

①肠系膜上动脉栓塞
②十二指肠23部损伤

房颤不能贸然的转复，防止心房恢复有效收缩使附壁血栓脱落，造成脑栓塞、肠系膜上动脉栓塞